

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

André Faro Pinto

IDADE: 46 PESO: 149 ALTURA: PROFISSÃO: ex da ex econômica
SINTOMAS: Sonolento / Dor de cabeça / memória ruim (esqueça)
QUEIXAS: Desanimado - *causado do acordo / edema mmf / pés (pulsos)
MEDICAMENTOS: Xigolín / Metformina / Parimida / Piran T4

MÉDICO: Dr. Graio - Dr. Orli - Dr. Vinícius

MARCAPASSO: () S ☒ AN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 20:00

HORA QUE DORME: 01:00 HORA QUE ACORDA: 08:00

COCHILHO (☒) SIM () NÃO 18-20 DORME ACOMPANHADO (☒) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (☒) NÃO cachorro / gato no quarto

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: Parou há 10 a.

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Oral BANHEIRO: 4 a 5X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Bronquite MALLAMPATI: IV ++ IAH: 98.5 e/ev SPO2: 77% Nadir 90%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Deu: D. Lateral

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor lombar / ↓ circulação

19/03 Avaliação PSG cl / CPAP = 10.5

24 P = 10.6 cmH₂O IAH = 49.6 e/ev

Dra. Ana Cláudia de Moraes
Fisioterapeuta
CREFITO 29544-F

26/03 P = 10.6 cmH₂O

24 IAH = 7.3 e/ev

m. de uso: 7h32'

Fuga = 12.2

melhora sonolência /
dor de cabeça / melhora
do desânimo.

05/04 P = 11 cmH₂O

IAH = 1.7 e/ev

m. de uso: 6h

fuga = 12.5 e/ev

acabou a dor de cabeça
sonolência acabou.
filtro e higiene ok
= boa

28/05 P = 11 cmH₂O

m. de uso: 6h

IAH = 0.6 e/ev

Fuga = 13.5 e/ev

- Não tem mais sonolência

- Peso = 143 kg.

29/07 P = 11 cmH₂O

IAH = 0.4 e/ev

m. de uso: 21.4 e/ev

boa

01/10 P = 11 cmH₂O

IAH = 0.6 e/ev

m. de uso: 6h9'

Bem adaptado

Peso - 133 Kg

boa

31/01
25

P = 11.0

IAH = 0.3

M. de uso = 6hr

fuga = 25 l/min.

trocar masc e fixador

fua Cláudio

28/04
25

P = 11.0 cmHg

IAH = 0.1 efv

M. de uso: 5h42'

fuga = 11.4 lpm.

troco o fixador

e filtro.

fua



CLÍNICA
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PINTES

CRM-SP 69.730

CRM-SP 82.858

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: André Faro Pinto

EXAME nº: 4347-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Adriano Baptista Mazer

DATA: 24/07/2019 - Segunda via em 22/07/2020

IDADE: 41 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h29min e concluído às 05h58min. A latência para o sono foi de 5 minutos e a latência para o estágio REM, de 147 minutos. O tempo total de sono foi de 391 minutos (06h31min), com eficiência de sono (T T S / T T R)* de 86,9%. A distribuição do sono mostrou 12,7% de estágio 1, 36,7% de estágio 2, 32,9% de estágio 3 e 17,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 53,5 minutos em vigília, ocorreram 260 microdespertares (índice: 39,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 49,6/hora, sendo 2 apneia/hora e 47,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 49,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 90% e a mínima de 61%.

(*) T T S ⇒ Tempo Total de Sono T T R ⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP, modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara facial Mirage Quattro large (Resmed®). A pressão final do CPAP foi de 10,5 cm de H₂O. Não foi possível aumentar ainda mais a pressão por causa de despertares e vazamentos. Ele roncou durante o exame.

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (49,6/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (49,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 66; máxima: 111 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 5 min; normal até 30 min) – ele usou um comprimido de Patz 5 mg às 22h20min. A latência para o estágio REM estava alongada (147 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (86,9%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 39,9/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,7%; normal: 8-10%) e 3 (32,9%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (36,7%; normal: 45-55%) e REM (17,8%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730